만성변비, 제대로 알고 치료하기

진단 기준부터 안전한 약·식사·생활습관까지 — 편안한 배변을 위한 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

만성변비 — 횟수가 아니라 '편하게 다 비우는가'

국제 진단 기준(로마 기준 IV)은 세 가지를 봅니다



1

3개월 넘게 이어집니다

6개월 전에 시작해 최근 3개월 동안 아래 불편이 계속되면 만성변비로 봅니다.

잠깐의 변비는 해당 안 됨



2

네 번에 한 번 이상 불편합니다

배변할 때 **네 번 중 한 번 이상** 힘주기·딱딱한 변·덜 나온 느낌·막힌 느낌·손으로 도와야 함 중 두 가지 이상.

불편 두 가지 이상



3

스스로 보는 횟수가 적습니다

약 없이 저절로 보는 배변이 **주 3회 미만**이면 함께 고려합니다.

주 3회 미만

Tip · 매일 못 봐도 정상일 수 있고, 매일 봐도 변비일 수 있습니다.

근거 · 로마 기준 IV · AGA/ACG 2023 만성변비 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

매일 보지 않아도 건강할 수 있습니다

횟수보다 '편안함'과 '다 비웠는가'가 더 중요합니다

변비가 아닙니다

주 3회 이상, **편하게** 봅니다.

- 매일 가지 않아도 편하면 정상입니다
- 매끈한 소시지 모양(3~4형) 변
- 힘주지 않고 한 번에 나옵니다
- 다 비운 느낌이 듭니다

vs

변비로 봅니다

매일 봐도 **불편하면** 변비입니다.

- 딱딱한 알갱이·덩어리 변(1~2형)
- 오래 힘을 줘야 나옵니다
- 덜 나온 느낌·막힌 느낌이 남습니다
- 치료 목표는 '매일'이 아니라 '편하게 다 비우기'

Tip · 2주 동안 배변 일기(횟수·모양·힘주기)를 써 오시면 진료에 큰 도움이 됩니다.

근거 · 로마 기준 IV · 브리스톨 대변 척도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

나의 변은 어떤 모양인가요?

브리스톨 대변 척도 — 1형(딱딱)부터 7형(물)까지, 목표는 3~4형

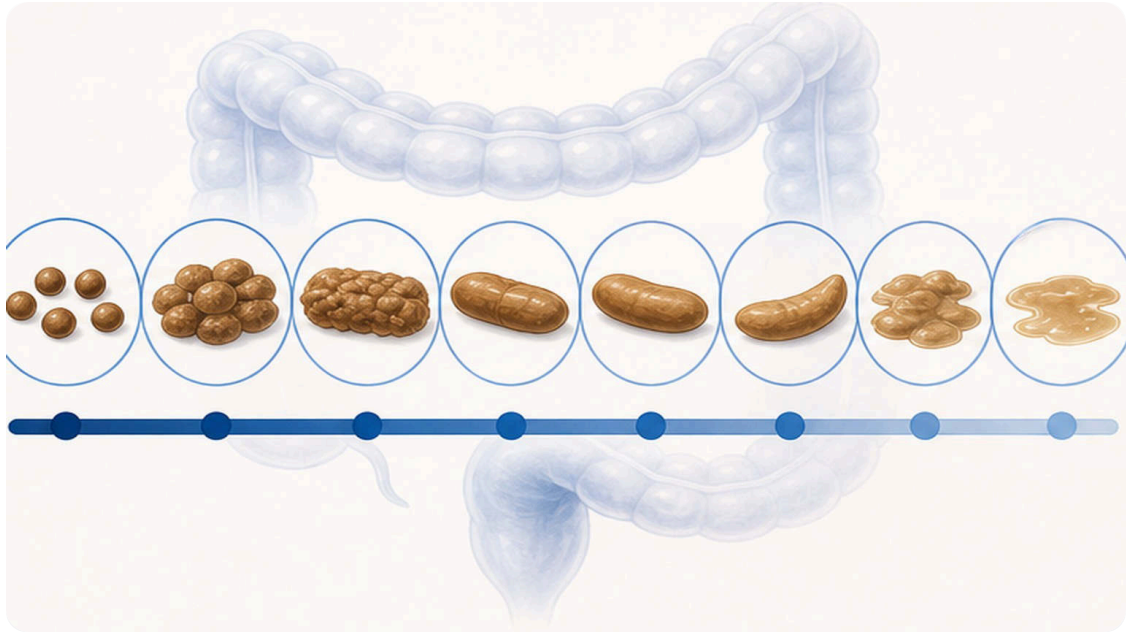


그림 · 왼쪽 딱딱한 알갱이(1형)에서 오른쪽 묽은 변(7형)으로 갈수록 장을 빨리 지나간 변입니다(설명용 그림).

1 **따로 떨어진 딱딱한 알갱이** 1형

심한 변비 — 힘주기·항문 통증·찢어짐이 잦습니다.

2 **울퉁불퉁 단단한 소시지** 2형

변비 — 식사·물 보강과 약이 도움이 됩니다.

3 **매끈한 소시지** 3~4형 · 목표

힘주지 않고 한 번에 나오는 **가장 좋은 변**입니다.

4 **부드러운 덩어리 → 진흙 → 물** 5~7형

설사 쪽 — 7형이 계속되면 탈수 위험이 있어 진료가 필요합니다.

Tip · 변을 보고 몇 형인지 적어 두면 치료 효과를 스스로 확인할 수 있습니다.

근거 · 브리스톨 대변 척도 · Heaton & Lewis 1997

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 신호가 있으면 꼭 진료를 받으세요

하나라도 있으면 단순 변비로 넘기지 말고 대장내시경 등 검사가 필요합니다

피가 섞인 변 · 빈혈

변에 피가 섞이거나 대변 잠혈 검사가 양성, 이유를 모르는 철 결핍 빈혈은 대장암의 신호일 수 있습니다.

나도 모르게 빠지는 체중

식사·운동 변화 없이 6개월 안에 체중이 5% 넘게 줄면 종양·대사 질환을 의심합니다.

50세 이후 새로 생긴 변비 · 가족력

중년 이후 처음 생긴 변비, 대장암 가족력, 최근 갑자기 달라진 배변 습관은 대장내시경이 필요합니다.

만져지는 덩어리 · 심한 팽만 · 구토

배나 항문에 덩어리가 만져지거나 배가 심하게 부르고 토하면 장이 막혔을 수 있어 바로 진료받습니다.

Tip · 경고 신호가 없으면 아래의 식사·생활습관·약으로 먼저 치료합니다.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 대한소화기학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

같은 변비라도 유형에 따라 치료가 다릅니다

정확히 나누는 것이 효과적인 치료의 시작입니다

장 운동은 정상 — 가장 흔함

변이 굳어 불편합니다. 배가 아프고 부글거리면 변비형 과민성장증후군입니다. **수용성 섬유질과 PEG**로 대부분 좋아집니다.

장이 느린 유형

며칠씩 변의가 없고 섬유질·일반 변비약이 잘 듣지 않습니다. **장 운동을 돕는 처방약**을 씁니다.

출구가 안 열리는 유형

힘줄 때 항문 주위 근육이 오히려 조입니다. 근육 푸는 법을 다시 익히는 **바이오피드백**이 약보다 낫습니다.



그림 · 느린 장(왼쪽), 출구 근육(가운데), 부글거리는 장(오른쪽) — 원인이 다른 세 가지 변비입니다(설명용 그림).

Tip · 장이 느린 유형은 섬유질만 늘리면 오히려 더 부를 수 있습니다.

근거 · 로마 기준 IV 유형 분류 · ACG 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

딱딱한 변만으로 변비형 IBS를 정하지 않습니다

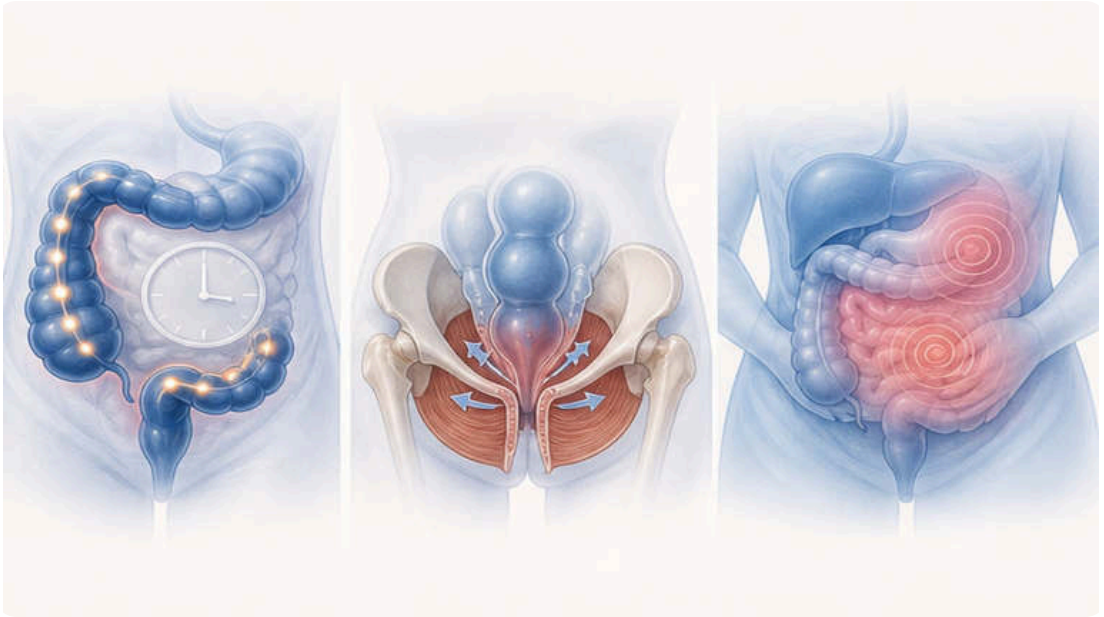
변비와 과민성 장증후군은 서로 겹치거나 양상이 달라질 수 있습니다.

변 모양과 횟수

딱딱한 변이나 적은 배변 횟수뿐 아니라 통증이 언제 생기는지도 함께 살핍니다. 브리스톨 대변형태의 1~2형은 딱딱한 변입니다.

반복되는 복통·불편감

배변, 배변 횟수 변화, 변 모양 변화와 통증이 관련되는지 살핍니다. 강의는 기능성 변비와 변비형 IBS 사이의 연속성을 설명했습니다.



장 운동·골반저 배변 과정과 복통을 설명한 그림입니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

강의에서 소개한 Rome V 기준

반복되는 복통 또는 복부 불편감과 배변 변화의 관계를 봅니다.

월 3일 이상

최근 3개월 동안

평균 월 3일 이상, 지속적이지 않고 반복되는 복통 또는 복부 불편감이 기준입니다. 증상 시작은 진단 최소 6개월 전이어야 합니다.

세 가지 중 두 가지 이상

배변과의 관련, 배변 횟수 변화, 대변 형태 변화 중 2가지 이상과 연결되는지 봅니다.

월경기간만의 증상은 제외

월경기간에만 나타나는 증상은 제외한다고 설명했습니다. 증상과 배변 양상을 진료에서 함께 평가합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

힘을 주어도 잘 나오지 않을 때

배변장애가 있는지 확인하는 별도의 검사 경로입니다.

1

증상 듣기

과도하게 힘을 주는지, 변이 막히는지, 잔변감이 심한지 살핍니다.

2

도움이 필요한지

손가락 관장 등 손으로 배변을 도와야 하는지도 알려 주세요.

3

항문직장 검사

필요하면 항문직장 내압검사와 풍선배출검사를 고려합니다.

4

결과에 맞춘 치료

배변장애가 확인되면 바이오피드백 같은 행동치료를 고려합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

완하제는 증상과 동반질환에 맞춰 고릅니다

정기욱 연자 Q&A · 변비와 복부팽만을 함께 살핍니다.

일반 변비 치료부터

변비형 IBS에서는 일반적인 변비 치료에 반응이 부족할 때 프루칼로프라이드 같은 약을 고려할 수 있다고 답했습니다.

락툴로스와 당뇨

일반 변비 치료 용량은 혈당에 미치는 영향이 대체로 크지 않지만 제품의 소량 당류, 복용량과 혈당 상태를 함께 봅니다.

가스·복부팽만

락툴로스가 가스나 복부팽만을 더할 수 있습니다. 배변 개선과 배의 불편함을 함께 보고 약을 조정합니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

심부전 퇴원 후에는 체중과 울혈 증상으로 이뇨제를 조절합니다

이상언 연자 Q&A · 퇴원 후 이뇨제 조절에 관한 답변입니다.

퇴원 시 이뇨제 용량

퇴원 시 먹는 이뇨제 용량은 체중 변화와 울혈 여부·증상을 보고 결정한다고 답했습니다.

체중과 울혈 증상

체중 변화, 부종과 숨참을 살펴 몸에 물이 쌓이는지 봅니다. 이뇨제는 이런 상태와 전해질·콩팥기능을 함께 보고 조절합니다.

복용약을 알리기

마그네슘 함유 완하제는 디곡신의 흡수를 낮출 수 있다고 답했습니다. 디곡신 등 복용약을 함께 알려 주세요.

추적 진료

퇴원 후 첫 외래를 약 2주 뒤에 보며 체중·전해질·BUN/Cr·NT-proBNP 등을 보고 조절하는 접근을 소개했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

배변 기록과 심부전 기록을 함께 봅니다

변비의 양상과 심부전 퇴원 후 이뇨제 조절을 구분합니다.

배변 쪽 기록

진료에서 변비의 양상을 구체적으로 설명합니다.

- 변 모양·횟수와 복통의 관계를 살핍니다.
- 잔변감·심한 힘주기·손으로 돕는 배변을 알립니다.
- PEG는 락툴로스보다 가스 발생이 적다고 설명했습니다.

vs

심부전이 함께 있다면

이상언 연자 Q&A의 체액 상태에 따른 조절입니다.

- 하루 체중과 부종·숨참의 변화를 봅니다.
- 현재 이뇨제와 디곡신 등 복용약을 알립니다.
- 퇴원 후 약 2주 외래에서 체중·전해질·콩팥기능을 보고 이뇨제를 조절하는 접근을 소개했습니다.

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오래 써도 되는 약과 가끔만 쓰는 약을 나눕니다

모든 변비약이 같지 않습니다 — 언제 먹고 언제 쉬는지는 변비약 안내문을 드립니다(마지막 장 링크)

약	얼마나 써도 되나
PEG(마크로골)	**오래 써도 안전합니다** — 장에 물을 붙잡아 변을 부드럽게 하고, 장을 자극하지 않아 내성·의존이 없습니다
산화마그네슘	효과적이지만 콩팥 기능이 떨어졌거나 나이가 많으면 혈중 마그네슘을 정기적으로 확인합니다
비사코딜(둘코락스)	장을 자극해 밀어내는 약 — 막혔을 때만 쓰는 **구조용**, 4주 이내로
센나·알로에·디톡스 차	'천연' 이름의 자극성 성분 — 오래 쓴 안전성 근거가 부족해 **매일 마시지 않습니다**



그림 · 물에 타 먹는 가루약(PEG), 알약, '천연' 차 — 성분에 따라 쓰는 기간이 다릅니다(설명용 그림).

Tip · 잘 듣지 않으면 장 운동을 돕는 처방약(리나클로타이드·프루칼로프라이드 등)도 지침이 권하는 선택지입니다.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

근거가 있는 식사 — 효과가 확인된 것부터

권하는 음식과 권하지 않는 음식

권합니다

효과가 확인된 것부터 차례로 해 봅니다.

- 그린키위 하루 2개(껍질 벗겨서)
- 차전자피 — 물 200mL 이상과 함께
- 푸룬(말린 자두) 하루 50~100g — 과민성장에는 맞지 않음
- 수용성 섬유질이 많은 채소·과일
- 비피더스 유산균 — 4주 넘게, 보조로

vs

권하지 않습니다

효과가 없거나 오히려 불편해집니다.

- 밀기울 — 가스·더부룩함이 심해질 수 있음
- 이눌린 — 과민성장 변비에서 배가 부름
- 알로에 전잎·숙변 제거 차·다이어트 차
- 변 연화제(도큐세이트) — 효과가 확인 안 됨
- 억지로 물을 많이 마시기 — 근거 부족

Tip · 물은 탈수를 막을 만큼이면 충분합니다 — 억지로 더 마신다고 변비가 낫지는 않습니다.

근거 · 만성변비 생활요법 근거 · 키위 무작위 연구 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

약보다 중요한 생활습관 여섯 가지

배변 습관을 다시 들이면 작은 실천이 큰 변화를 만듭니다

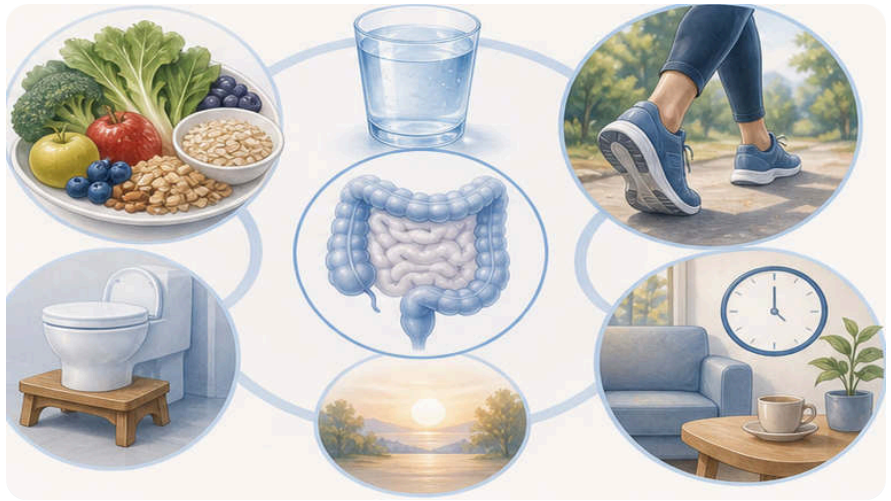


그림 · 먹고, 마시고, 걷고, 정해진 시간에 발판을 딛고 앉는 하루 (설명용 그림).

1. **변의가 오면 참지 않기** 가장 중요
   참기를 되풀이하면 신호를 못 느끼게 됩니다.
2. **식후 15~30분에 앉아 보기** 식후
   밥을 먹으면 장이 움직이는 반사가 가장 강합니다.
3. **같은 시간에 5~10분** 매일
   아침 식사 뒤처럼 시간을 정해 두면 장 리듬이 생깁니다.
4. **하루 30분 걷기** 가벼운 운동
   걷기·요가 정도로 충분합니다.
5. **물은 하루 1.5~2L** 탈수 막기
   더 많이 마신다고 낫지는 않습니다.
6. **발판 딛고 앉기** 선택
   무릎이 올라가 나오는 길이 곧게 펴집니다.

Tip · 변비의 가장 큰 적은 '참는 습관'입니다.

근거 · ACG 2021 생활요법 · 배변 훈련 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

기본 치료로 안 좋아지면 — 단계별로 찾아갑니다

식사·생활습관·일반 변비약으로도 나아지지 않을 때

1

기본 치료 점검

6개월 넘게

식사·습관·변비약에도 계속되면, 먹는 약 중 원인이 있는지 봅니다.

2

항문·직장 검사

전문 검사

항문 근육 압력을 재는 검사와 작은 풍선을 밀어내 보는 검사로 출구 기능을 봅니다.

3

유형 확정

진단

출구형·느린 장·섞인 형 중 어디인지 정합니다.

4

맞춤 치료

치료

출구형은 바이오피드백 4~6회, 느린 장은 장 운동을 돕는 처방약.

최근 시작한 약을 확인하세요 진통제·칼슘제·철분제·혈압약·항우울제가 변비를 일으킬 수 있습니다.

Tip · 새로 생긴 변비라면 최근 바뀐 약부터 진료 때 알려 주세요.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 대한소화기기능성질환·운동학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

변비는 참는 병이 아니라 치료하는 병입니다

01 목표는 '매일'이 아니라 '편하게 다 비우기'

02 PEG(마크로골)는 오래 써도 장을 망가뜨리지 않습니다

03 '천연·디톡스 차'를 매일 마시는 것이 가장 위험합니다

04 변의가 오면 바로 — 참는 것이 가장 큰 적

05 그린키위 2개 + 차전자피 + 적당한 물로 시작

06 '출구가 막힌 느낌'이 계속되면 바이오피드백

07 50세 이후 새 변비·피 섞인 변·체중 감소는 대장내시경

08 2주 배변 일기를 써서 진료 때 함께 봅니다

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든 물어보세요.

근거 · AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · 로마 기준 IV

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 약 사용 카드는 변비약 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

만성변비로 불편한 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 약 선택과 검사는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

AGA/ACG 2023 만성변비 지침 · ACG 2021 · 로마 기준 IV · 브리스톨 대변 척도 · 대한소화기학회 · 키위 무작위 연구 2021

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요